

EXÁMEN RESIDENCIAS MÉDICAS

LLAMADO A EXAMEN ÚNICO PARA SELECCIÓN DE
RESIDENTES - 2016

Cuadernillo: MEDICINA BÁSICO - A

1) Una paciente de 40 años de edad, con antecedentes de esterilidad primaria viene a la consulta para una segunda opinión porque refiere dismenorrea en aumento durante el último año, dispareunia profunda y dolor al defecar durante la menstruación. La ecografía muestra un mioma subseroso de 6cm, quistes ováricos bilaterales con contenido ecogénico denso sin vascularización al Doppler, y un CA 125 de 79. Al tacto hay dolor en el fondo de saco y el útero está fijo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A- Cáncer de ovario.

B- Endometriosis.

C- Tumor dermoide.

D- Disgerminoma.

2) Mujer de 60 años, que uso durante 6 años etinilestradiol y medroxiprogesterona como terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál de las siguientes complicaciones posibles, pueden deberse al aumento del riesgo absoluto por el uso de TRH?

A- Enfermedad coronaria.

B- Cáncer de mama.

D- Cáncer colorrectal.

E- Tromboembolismo pulmonar.

3) ¿Cuál neoplasia primaria de la mama es la que representa la mayor incidencia?

A- Carcinoma Lobulillar.

B- Carcinoma Ductal.

C- Sarcoma Filoideas.

D- Fibrosarcoma.

4) El síndrome de Mondor, se presenta como complicación del:

A- Desprendimiento de placenta normo inserta.

B- Placenta previa.

C- Acretismo placentario.

D- Aborto séptico.

5) ¿Cuál es la complicación materno fetal más frecuente durante la ruptura prematura de membrana?

A- Corioamnionitis.

B- Procidencia de cordón.

C- Cesárea.

D- Hipertonía uterina.

6) Paciente de 27 años, tercigesta, secundípara, quien cursa embarazo de 29 semanas, consulta a guardia por pérdida de líquido por genitales externos. Al examen físico se encuentra lúcida, afebril con TA 110/60 mmHg, tono uterino normal, dinámica uterina aislada y mov. fetales positivos, FCF: 140 por minuto. Al tacto vaginal se constata cuello posterior, permeable al dedo, formado, membranas rotas, líquido amniótico claro y presentación cefálica móvil. ¿Cuál es la conducta adecuada?

A- Internación, antibióticos endovenosos y esperar evolución espontánea por vía vaginal.

B- Internación, antibióticos endovenosos y maduración pulmonar fetal con corticoides.

C- Internación, antibióticos endovenosos y cesárea.

D- Internación, antibióticos endovenosos, maduración pulmonar fetal con corticoides e inmediata inducción del parto.

7) ¿Cuál de las siguientes es una modificación fisiológica en el aparato CARDIOVASCULAR durante el embarazo?

- A- Corazón en posición horizontalizado.
 - B- Segundo ruido desdoblado amplio y fijo.
 - C- Cuarto ruido intenso con bradicardia.
 - D- Soplo mesodiastólico.
-

8) ¿Cuál es la anemia más frecuente asociada con el embarazo?

- A- Por déficit de ácido fólico.
 - B- Por déficit de vitamina B12.
 - C- Por déficit de vitamina C.
 - D- Por déficit de hierro.
-

9) El descenso fetal a través del canal del parto recorre los planos de HODGE. Marque la opción CORRECTA respecto al segundo plano de HODGE.

- A- Pasa por el borde inferior de la sínfisis pubiana y cae por detrás en la parte media de la segunda vértebra sacra.
 - B- Pasa por el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio.
 - C- Pasa por las espinas ciáticas y llega por detrás a la articulación entre la cuarta y la quinta vértebra sacra.
 - D- Pasa por la punta del cóxis.
-

10) ¿Cuál de los siguientes fármacos es el de primera elección en la embarazada con hipertensión arterial crónica?

- A- Captopril.
 - B- Candesartán.
 - C- Alfametildopa.
 - D- Nifedipina.
-

11) La obesidad, la hipertensión arterial, la esterilidad, la menopausia tardía, los ciclos monofásicos y la diabetes son factores de riesgo para:

- A- Cáncer de endometrio.
 - B- Cáncer de ovario.
 - C- Cáncer de cuello uterino.
 - D- Cáncer de mama.
-

12) ¿Cuál de las siguientes vacunas está indicada en el embarazo?

- A- Rubéola.
 - B- Triple bacteriana acelular.
 - C- Sarampión.
 - D- Parotiditis.
-

13) Se presenta a la consulta una paciente cursando embarazo de 10 semanas de edad gestacional, al examen físico presenta TA 150/100 sin referir síntomas y el laboratorio de rutina dentro de parámetros normales. ¿Cuál es su diagnóstico probable?

- A- Hipertensión gestacional.
 - B- Pre-eclampsia leve.
 - C- Hipertensión arterial crónica.
 - D- Eclampsia.
-

14) El quiste dermoide o teratoma ovárico es:

- A- Tumor maligno.
 - B- Tumor benigno de línea germinal.
 - C- Tumor benigno de línea epitelial.
 - D- Tumor pre-maligno.
-

15) ¿Cuál neoplasia primaria de la mama es la que representa la mayor incidencia?

- A- Carcinoma lobulillar.
 - B- Carcinoma ductal.
 - C- Sarcoma Filoideo.
 - D- Fibrosarcoma.
-

16) En relación a la resonancia magnética de mama, marque la afirmación correcta:

- A- Es útil en el diagnóstico de las complicaciones de los implantes mamarios.
 - B- Tiene alta sensibilidad en el diagnóstico del cáncer de mama invasor.
 - C- Indicada para descartar multicentricidad y multifocalidad.
 - D- Indicada para diferenciar nódulos benignos de malignos.
-

17) ¿Cuál es el tumor benigno de mama más frecuente?

- A- Fibroadenoma.
 - B- Adenoma de pezón.
 - C- Papiloma intraductal.
 - D- Tumor Filoideo.
-

18) El máximo crecimiento longitudinal de la mujer ocurre durante la pubertad:

- A- Antes de la telarca.
 - B- Antes de la menarca.
 - C- Después de la menarca.
 - D- No hay un patrón pues se rige por códigos genéticos.
-

19) ¿Cuál es la capa más interna de las membranas ovulares?

- A- La capa corial.
 - B- El amnios.
 - C- El espacio intervelloso.
 - D- La decidua.
-

20) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas permite realizar diagnóstico diferencial entre pre-eclampsia y eclampsia?

- A- Proteinuria mayor a 2gr en 24hs.
 - B- Recuento plaquetario menor a 100.000 por mm³.
 - C- Convulsiones.
 - D- Trastornos visuales.
-

21) ¿Cuál de los siguientes es criterio mayor de Enfermedad Pélvica Inflamatoria?

- A- Fiebre.
 - B- Masa anexial palpable.
 - C- Dolor a la movilización uterina.
 - D- Leucocitosis.
-

22) A una gestante a término que ingresa en trabajo de parto se le detectan unas pequeñas vesículas vulvares de herpes simple recidivante. Años antes de la gestación tuvo una primoinfección de herpes genital. ¿Cuál es la conducta a seguir?

- A- Hacer una cesárea.
 - B- Permitir el parto vaginal y tratar con aciclovir al recién nacido.
 - C- No es necesaria una conducta especial ya que el herpes recidivante no tiene riesgo para el recién nacido.
 - D- Tratar inmediatamente las lesiones con ácido tricloroacético y luego permitir el parto vaginal.
-

23) Se define por osteoporosis:

- A- Densidad mineral ósea de 1.0 desvíos estándar.
 - B- Densidad mineral ósea de 2.5 desvíos estándar.
 - C- Es una etapa previa a la osteopenia.
 - D- Densidad mineral ósea de 2.5 desvíos estándar.
-

24) ¿Cuáles son las ventajas de la mamografía digital?

- A- Aumentó la detección de cáncer de mama.
 - B- Aumentó la necesidad de repetir exámenes.
 - C- Capacidad de manipular las imágenes para mejorar el diagnóstico.
 - D- Solo tiene ventajas la mamografía digital directa.
-

25) El síntoma más frecuente de micosis vaginal es:

- A- Leucorrea fétida.
 - B- Dispareunia.
 - C- Prurito.
 - D- Leucorrea abundante grisácea.
-

26) El tratamiento en un niño en edad escolar con NEUMONÍA DE LA COMUNIDAD NO SEVERA incluye:

- A- Medidas de sostén, antibióticos vía oral y kinesiterapia respiratoria precoz.
 - B- Antibióticos vía oral, medidas de sostén en su domicilio, información sobre signos de alarma y control a las 24-48hs.
 - C- Antitérmicos inyectables, antibióticos inyectables y expectorantes vía oral.
 - D- Broncodilatadores y corticoides sistémicos.
-

27) Federico tiene 15 años, consulta por astenia, fiebre y dolor de garganta. En el examen físico usted constata adenopatías generalizadas, faringitis intensa, esplenomegalia, y un exantema, que según el paciente apareció luego de comenzar tratamiento con amoxicilina, su diagnóstico presuntivo es:

- A- Faringitis estreptocócica.
 - B- Herpangina.
 - C- Escarlatina.
 - D- Mononucleosis.
-

28) Usted controla a Lucas, de 10 años de edad, quien padece un Síndrome de Marfán. Al examen físico presenta un soplo cardíaco, ¿cuál es la cardiopatía que más se asocia con este síndrome?

- A- Estenosis pulmonar.
 - B- Prolapso de la válvula mitral.
 - C- Estenosis aórtica.
 - D- Comunicación interauricular.
-

29) ¿?

30) La causa más común de PARO cardíaco neonatal, obedece a:

- A- Cardiopatía congénita no cianosante.
 - B- Infección respiratoria perinatal.
 - C- Problemas endócrinos.
 - D- Meningitis o encefalitis.
-

31) Un niño de 2 años consulta por fiebre de 6 días de evolución, tiene inyección conjuntival, labios secos y resquebrajados, lengua aframbuesada, adenomegalia submaxilar y exantema macular generalizado. A las 48hs se agrega descamación subungueal. El diagnóstico clínico corresponde a:

- A- Escarlatina.
 - B- Sarampión.
 - C- Síndrome de Kawasaki.
 - D- Eritema infeccioso.
-

32) Consulta paciente varón de 14 años quien refiere dolor sordo leve en zona del testículo izquierdo. Al examinarlo usted nota una tumoración paratesticular que a la palpación recuerda a una bolsa de gusanos. Usted cree que puede corresponder a:

- A- Torsión del testículo.
 - B- Varicocele.
 - C- Hernia inguinal.
 - D- Hidrocele.
-

33) Usted atiende a un escolar de 7 años que presenta desde el día anterior lesiones pápulo-vesiculares en cabeza, cavidad oral, cuello y tronco. Está febril y en buenas condiciones generales. El diagnóstico más probable es:

- A- Varicela.
 - B- Herpangina.
 - C- Prúrigo sobreinfectado.
 - D- Gingivoestomatitis herpética.
-

34) El primer signo visible de inicio de la pubertad en la mujer es:

- A- La presencia de vello pubiano a los 10 años.
 - B- La menarquia.
 - C- El desarrollo del botón mamario en niñas mayores de 8 años.
 - D- El aumento de peso a expensas de hiperplasia del tejido adiposo en la primera etapa de la pubertad.
-

35) Consulta por guardia un paciente de 12 años con gastroenteritis invasiva que presenta una convulsión. ¿En cuál de los siguientes agentes etiológicos pensaría?

- A- Salmonella.
 - B- E. coli enteroinvasiva.
 - C- Yersinia.
 - D- Shigella.
-

36) ¿Cuál de estas situaciones representa una contraindicación absoluta de lactancia?

- A- Plaquetopenia de la madre.
 - B- VIH materno.
 - C- Madre hipotiroidea medicada.
 - D- Desnutrición materna.
-

37) Un niño de 2 años de edad es picado por un alacrán. La madre trae el escorpión y resulta ser de la variedad Tityus Trivittatus. ¿Cuál es la sintomatología esperable en ese niño en caso de presentarse con un cuadro moderado a severo?

- A- Necrosis en el sitio de la picadura, hipoglucemia y fallo renal por hemólisis.
 - B- Palidez, vómitos, hipersecreción, arritmias e hiperglucemia.
 - C- Sólo dolor local ya que ésta no es una especie peligrosa.
 - D- Sequedad de mucosas, eritema generalizado y fiebre.
-

38) ¿Cuál de los siguientes agentes produce miocarditis con más frecuencia en pediatría?

- A- Staphylococcus aureus.
 - B- Streptococos.
 - C- Virus coxsackie.
 - D- Listeria.
-

39) Señalar lo correcto en relación con la meningitis bacteriana aguda en pediatría:

- A- La forma de presentación más frecuente es inicio súbito, con síntomas de shock, púrpura y letargo.
 - B- En la mayoría de los casos, la meningitis viene precedida por varios días de fiebre, síntomas gastrointestinales o respiratorios, letargia e irritabilidad progresiva.
 - C- El antecedente de rinosinusitis aguda está presente en la mayoría de los casos.
 - D- Las alteraciones del nivel de conciencia no son frecuentes.
-

40) Señale lo correcto en relación con la varicela en pediatría:

- A- El máximo riesgo de contagiosidad es cuando caen las costras.
 - B- Las lesiones aparecen primero en miembros inferiores.
 - C- Se puede asociar a complicaciones graves: sobreinfección bacteriana, neumonía.
 - D- El tratamiento antivírico no modifica el curso de la enfermedad.
-

41) En niños, la cistitis hemorrágica, conjuntivitis, neumonía y diarrea, se asocian etiológicamente con:

- A- Virus respiratorio sincitial.
 - B- Adenovirus.
 - C- Mycoplasma.
 - D- Herpesvirus.
-

42) Señale la afirmación correcta en relación a la ictericia fisiológica del recién nacido:

- A- Comienza a ser visible al 2do o 3er día de nacimiento.
 - B- Se debe al aumento de bilirrubina directa en sangre.
 - C- Se debe a la alteración en la excreción de bilirrubina conjugada.
 - D- Es normal que aumente más de 5gr/dL/24hs.
-

43) Niño de 10 años con episodios breves de distracciones (< 1 minuto) en los que no responde a llamadas y parpadea. Un EEG muestra descargas punta-onda a 3 ciclos por segundo. El tratamiento electivo de primera línea lo haría con:

- A- Valproato.
 - B- Carbamacepina.
 - C- Fenitoína.
 - D- Gabapentina.
-

44) La fontanela anterior se cierra a la edad de:

- A- Entre los 2 y 6 meses.
 - B- Entre los 4 y 6 meses.
 - C- Entre los 9 y 18 meses.
 - D- Entre los 18 y 24 meses.
-

45) Una niña de 3 meses de vida, vomita cada día desde que nació y ha tenido dos cuadros de deshidratación grave sin antecedentes de gastroenteritis. Tiene desnutrición moderada y en el laboratorio solicitado presenta Na: 123 mEq/L y K: 7,8 mEq/L. ¿Cuál de los siguientes trastornos endocrinológicos es el más probable?

- A- Necrosis suprarrenal secundaria.
- B- Hiperplasia suprarrenal congénita.
- C- Neuroblastoma suprarrenal.
- D- Insuficiencia hipofisaria.

46) Cuando se le administra hierro a una paciente con anemia ferropénica, se produce un aumento de reticulocitos. ¿Cuándo aparece esta reticulocitosis?

A- A los 3 o 4 días de iniciado el tratamiento.

B- A los 8 o 12 días.

C- A los 20 o 30 días.

D- A los 2 o 3 meses.

47) ¿Cuál de los siguientes virus es el más frecuentemente implicado en la etiología de la bronquiolitis y neumonía viral del lactante?

A- Adenovirus.

B- Virus respiratorio sincitial.

C- Metapneumovirus.

D- Virus de la gripe.

48) La glomerulonefritis postestreptocócica se caracteriza por:

A- Es frecuente en niños menores de 3 años.

B- Siempre se acompaña de insuficiencia renal.

C- El tratamiento precoz de la faringitis bacteriana con antibioticoterapia sistémica elimina el riesgo de glomerulonefritis.

D- El paciente típico desarrolla un síndrome nefrítico al cabo de 1 o 2 semanas de presentar una faringitis estreptocócica.

49) Le consultan por una paciente de 8 meses, con síntomas respiratorios a repetición, retraso del crecimiento, diarrea prolongada, antecedentes de íleo meconial y prolapso rectal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A- Neumonía a repetición por alteraciones anatómicas.

B- Síndrome de cilios inmóviles.

C- Reflujo gastroesofágico patológico.

D- Fibrosis quística.

50) Un RN que nace con 30 semanas de gestación, desarrolla Síndrome de Dificultad Respiratoria durante las 24 horas de vida. El diagnóstico más probable sería:

A- Enfermedad de membranas hialinas o SDR tipo I.

B- Síndrome de aspiración de meconio.

C- Insuficiencia cardíaca por ductus permeable.

D- Ventriculo único.

51) Las adenopatías de los linfomas de Hodgkin:

A- En el 80% de los casos se localizan a nivel inguinal.

B- Son duras y dolorosas a la palpación.

C- Son renitentes e indoloras.

D- Se adhieren a los planos profundos.

52) ¿Cuál de los siguientes es un criterio mayor de Duke para el diagnóstico de Endocarditis Infecciosa?

A- Hemocultivos positivos para gérmenes típicos.

B- Manchas de Roth.

C- Nódulos de Osler.

D- Esplenomegalia.

53) Una paciente de 64 años, diabética y depresiva, cumple tratamiento con 5mg de glibenclamida y 75mg de amitriptilina, presenta depresión del sensorio. ¿Cuál sería el primer diagnóstico a considerar?

A- Accidente cerebrovascular.

B- Intoxicación aguda por amitriptilina.

C- Crisis histérica.

D- Hipoglucemia.

54) Concorre a su consultorio una paciente de 27 años de edad buscando "medicación" para perder peso. No se constatan enfermedades sistémicas. Al examen se evidencia altura 167cm, peso 63kg, índice de masa corporal: 22. Ud decide:
A- De acuerdo al examen, la paciente debe comenzar tratamiento conservador con dieta y ejercicio.
B- Decide comenzar con ensayo previo de 2-4 semanas con cambios dietéticos y ejercicios antes de iniciar la farmacoterapia.
C- La paciente no tiene sobrepeso. Decide realizar consejería sobre mantenimiento de peso.
D- Decide considerar tratamiento quirúrgico debido a la dificultad para perder peso con otros métodos.

55) ¿Cuál de los siguiente anticuerpos es el más específico de la anemia perniciosa?
A- Anti factor intrínseco.
B- Anti mitocondriales.
C- Anti parietales gástricos.
D- Anti nucleares.

56) ¿Cuál de las siguientes es causa de insuficiencia aórtica aguda?
A- Degeneración mixomatosa.
B- Fiebre reumática.
C- Dehiscencia de válvula protésica.
D- Aortitis.

57) El pulso paradojal se encuentra en:
A- Insuficiencia aórtica.
B- Pericarditis aguda.
C- Taponamiento cardíaco.
D- Insuficiencia mitral.

58) ¿En qué circunstancia el pulso de la arteria humeral izquierda es menor que el de la derecha?
A- Coartación aórtica anterior al nacimiento de la subclavia izquierda.
B- Aneurisma aórtico.
C- Coartación aórtica posterior al nacimiento de la arteria subclavia.
D- Coartación aórtica posterior al nacimiento de la arteria subclavia derecha.

59) ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente en el mesotelioma pleural?
A- Disnea.
B- Tos no productiva.
C- Dolor torácico.
D- Hemoptisis.

60) En un paciente con sospecha de hipertiroidismo primario, ¿qué espera encontrar en el laboratorio?
A- TSH suprimida, T3, T4 y T4 libre elevadas.
B- TSH suprimida, T3, T4 y T4 libre suprimidas.
C- TSH elevada, T3, T4 y T4 libre suprimidas.
D- TSH normal con T3, T4 y T4 libre elevadas.

61) Las palpitaciones de comienzo brusco, rápidas e irregulares se asocian a:
A- Extrasístoles auriculares.
B- Extrasístoles ventriculares.
C- Fibrilación auricular paroxística.
D- Taquicardia sinusal.

62) Usted define crisis isquémica transitoria como:

- A- Disfunción neurológica transitoria por isquemia sin infarto.
 - B- Disfunción neurológica transitoria por isquemia con infarto.
 - C- Disfunción neurológica permanente por isquemia con infarto.
 - D- Crisis de ausencia sin convulsiones.
-

63) ¿A qué familia de virus pertenece el virus de la hepatitis A?

- A- Picornavirus.
 - B- Hepadnavirus.
 - C- Calcivirus.
 - D- Flavivirus.
-

64) Durante el examen clínico de un paciente portador de un nódulo tiroideo ¿Cuál sería el algoritmo diagnóstico inicial?

- A- Ecografía, TSH y T4.
 - B- PAAF.
 - C- Centellografía tiroidea.
 - D- TSH y T4.
-

65) El patrón típico del líquido cefalorraquídeo de un paciente con meningitis bacteriana es:

- A- Leucocitos aumentados con predominio de polimorfonucleares, hipogluorraquia, proteínas elevadas y presencia de bacterias.
 - B- Sin leucocitos, gluorraquia aumentada, proteinorraquia disminuida.
 - C- Leucocitos aumentados con predominio linfocítico, gluorraquia normal, proteinorraquia aumentada y presencia de bacterias.
 - D- Leucocitos aumentados con predominio de polimorfonucleares, hipogluorraquia, proteínas disminuidas y presencia de bacterias.
-

66) ¿Cuál de estas patologías produce un derrame pleural tipo trasudado?

- A- Artritis reumatoidea.
 - B- Cáncer de pulmón.
 - C- Cáncer de ovario.
 - D- Insuficiencia cardíaca.
-

67) Referido a los síntomas y signos del Síndrome de Cushing:

- A- El hirsutismo y el aumento del peso corporal se encuentra en casi el 10% de los pacientes.
 - B- El edema es característico de la enfermedad.
 - C- La HTA sistólica se presenta en el 20% de los pacientes.
 - D- La fatiga y la debilidad son síntomas generales muy comunes.
-

68) La causa más frecuente de síndrome de hipertensión portal es:

- A- Insuficiencia cardíaca.
 - B- Hepatitis alcohólica.
 - C- Cirrosis hepática.
 - D- Metástasis hepática.
-

69) La talasemia se diferencia de la anemia ferropénica porque:

- A- Es una anemia microcítica hipocrómica.
 - B- Cursa con hierro normal o alto.
 - C- Tiene baja saturación de transferrina.
 - D- Presenta ferritina baja.
-

70) En el estadio inicial ¿cuál es la forma de presentación clínica más frecuente de la glomerulonefritis membranosa?

- A- Síndrome nefrótico.
 - B- Síndrome nefrítico.
 - C- Síndrome urémico.
 - D- Insuficiencia renal aguda.
-

71) ¿Cuál es la etiología más frecuente de bronquiectasias en países subdesarrollados?

- A- Trastornos genéticos.
 - B- Inmunodeficiencias.
 - C- Post-infecciosa.
 - D- Asma-sinusitis.
-

72) ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es la más frecuente en los pacientes con disección aórtica?

- A- Insuficiencia aórtica.
 - B- Dolor.
 - C- Desaparición de pulsos periféricos.
 - D- Fiebre.
-

73) El síndrome de derrame pleural se caracteriza por:

- A- Ser una alteración ventilatoria obstructiva.
 - B- Cursar con aumento de las vibraciones vocales.
 - C- Presentar matidez pulmonar y de columna vertebral.
 - D- Tener crepitantes y subcrepitantes bilaterales.
-

74) ¿Cuál de los siguientes forma parte de los criterios mayores de Duke para Endocarditis Infecciosa?

- A- Hemocultivos positivos para gérmenes típicos.
 - B- Manchas de Roth.
 - C- Nódulos de Osler.
 - D- Esplenomegalia.
-

75) Consideramos que una enfermedad es pandémica cuando:

- A- Es de distribución local.
 - B- Es de distribución zonal.
 - C- No se la conoce.
 - D- Es de distribución mundial.
-

76) El ABDOMEN AGUDO VASCULAR se caracteriza por:

- A- Es el abdomen agudo de mayor frecuencia.
 - B- Predomina en pacientes mayores de 60 años.
 - C- Tiene un comienzo insidioso.
 - D- El dolor abdominal es poco intenso.
-

77) Paciente de 19 años de sexo masculino, longilíneo, consulta por presentar dolor en hemitórax izquierdo, que se exacerba con la inspiración profunda, de aparición brusca. Al examen físico se constata disminución del murmullo vesicular en campo superior izquierdo, aumento de la sonoridad a la percusión y disminución de las vibraciones vocales. ¿Cuál es su impresión diagnóstica?

- A- Síndrome de condensación.
 - B- Atelectasia.
 - C- Neumotórax.
 - D- Derrame pleural.
-

78) Un testículo criptorquídico de localización abdominal no adecuadamente tratado puede traer aparejado:

- A- Mayor esterilidad por compromiso inmunológico del testículo normal.
 - B- Mayor tendencia hernia inguino-escrotal.
 - C- Mayor riesgo cancerígeno en ese testículo.
 - D- Atrofia parcial del mismo con espermatogénesis indemne.
-

79) ¿Qué sector del intestino irriga la arteria mesentérica superior?

- A- Todo el intestino delgado.
 - B- Todo el intestino grueso.
 - C- Colon derecho y todo el delgado.
 - D- Colon izquierdo, sigmoides y el recto superior.
-

80) La tríada de dolor abdominal, vómitos y fiebre leve en un niño de edad escolar, debe siempre pensar primero el diagnóstico de:

- A- Úlcera péptica.
 - B- Hernia atascada.
 - C- Enteritis viral aguda.
 - D- Apendicitis aguda.
-

81) La vena safena interna, se origina:

- A- Por detrás del maléolo externo.
 - B- Por detrás del maléolo interno.
 - C- Por delante del maléolo externo.
 - D- Por delante del maléolo interno.
-

82) Señale las ramas del tronco celíaco:

- A- Hepática común, mesentérica superior, esplénica.
 - B- Hepática común, esplénica, coronaria estomáquica.
 - C- Hepática común, mesentérica superior y gástrica derecha.
 - D- Hepática común, mesentérica superior y gástrica izquierda.
-

83) ¿Cuál es la neoplasia anal más frecuente?

- A- Carcinoma indiferenciado.
 - B- Adenocarcinoma.
 - C- Melanomas.
 - D- Carcinoma epidermoide.
-

84) ¿Cuál es el factor etiopatogénico más frecuente de las pancreatitis crónicas?

- A- Idiopática.
 - B- Alcoholismo.
 - C- Litiasis biliar.
 - D- Traumatismos.
-

85) El examen físico de un paciente con sospecha de ABDOMEN AGUDO PERFORATIVO nos muestra:

- A- Ausencia de irritación peritoneal.
 - B- Signo de Gueneau de Mussy ausente.
 - C- Signo de Jobert negativo.
 - D- Abdomen en tabla.
-

86) En la percusión abdominal, la matidez de concavidad superior es signo de:

- A- Quiste de ovario.
 - B- Embarazo.
 - C- Ascitis.
 - D- Globo vesical.
-

87) La clasificación de Hinchey se utiliza en:

- A- Apendicitis aguda.
 - B- Diverticulosis.
 - C- Diverticulitis complicada.
 - D- Tumor de recto sigma.
-

88) ¿Cuál es la posición más frecuente del apéndice cecal?

- A- Descendente interno.
 - B- Ascendente interno.
 - C- Subcecal.
 - D- Paracólico derecho.
-

89) ¿Dónde se encuentran ubicadas las válvulas de Heister?

- A- Vesícula biliar.
 - B- Conducto cístico.
 - C- Colédoco.
 - D- Recto.
-

90) Ante la palpación de una vesícula distendida e indolora en un paciente icterico con síndrome constitucional. ¿Qué diagnóstico sospecha?

- A- Carcinoma vesicular.
 - B- Coledocolitiasis.
 - C- Tumor de Klatskin.
 - D- Carcinoma periampular.
-

91) El divertículo de Meckel se encuentra en:

- A- El ciego.
 - B- Aproximadamente a 40cm del ciego.
 - C- En el colon sigmoide.
 - D- En el intestino delgado a centímetros de la válvula íleocecal.
-

92) ¿Cuál de las siguientes es una característica del carcinoma de colon derecho?

- A- Lesión anular.
 - B- Generalmente escamoso.
 - C- Suele ser escirro.
 - D- Se asocia con anemia.
-

93) La intervención quirúrgica que establece una comunicación entre el estómago y la piel recibe el nombre de:

- A- Gastrotomía.
 - B- Gastrostomía.
 - C- Gastrectomía.
 - D- Gastropexia.
-

94) ¿Cuál es la principal causa de síndrome coledociano benigno?

A- Lesión quirúrgica.

B- Litiasis.

C- Ampuloma.

D- Odditis.

95) ¿Cuál de los siguientes factores probablemente está relacionado con mayor incidencia de cáncer gástrico?

A- Factores dietéticos.

B- Grupo sanguíneo A.

C- Gastritis atrófica.

D- Aclorhidria.

96) Ante la sospecha clínica de oclusión intestinal, el primer estudio que debe solicitar es:

A- Ecografía.

B- Radiografía simple de abdomen.

C- Radiografía seriada de intestino delgado.

D- Tomografía.

97) La velocidad de segmentación globular en una apendicitis aguda se haya habitualmente:

A- Muy elevada.

B- Moderadamente elevada.

C- Elevada.

D- Dentro de límites normales.

98) ¿Cuál de las siguientes es una característica de la colesterosis?

A- Depósitos de colesterol en las paredes arteriales endocraneales.

B- Múltiples cálculos de colesterol intracoledocianos.

C- Patología vesicular caracterizada por depósitos de colesterol en sus paredes.

D- Degeneración de las paredes del intestino delgado por depósito de cristales de colesterol.

99) ¿Cuál es la localización más frecuente de Diverticulosis colónica?

A- Ciego.

B- Sigmoide.

C- Recto.

D- Colon ascendente.

100) Los síntomas y signos de la "tríada de Charcot" son diagnóstico de:

A- Pancreatitis aguda.

B- Colangitis aguda.

C- Diverticulitis aguda.

D- Divertículo duodenal.